PENCEGAHAN PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH PADA PEREMPUAN

Dr. dr. Dyana Sarvasti, SpJP(K), FIHA, FAsCC
Fakultas Kedokteran Unika Widya Mandala Surabaya
RS Husada Utama Surabaya



LEVEL PREVENSI PENYAKIT KARDIOVASKULAR

1. Prevensi Primordial
2. Prevensi Primer
3. Prevensi Sekunder

CHARACTERISTIC	PRIMORDIAL	PRIMARY	SECONDARY
Target patients	All patients, including children	Patients at increased risk for CVD	Patients with known CVD
Setting	Community, societal	Outpatient	Inpatient transitioning to outpatient
Delivery of care	• Policy decisions • Dietary patterns • Education campaigns • Environment	• Education campaigns • Behavioral intervention • Medications	• Behavioral intervention • Medications • Rehabilitation
Advantages	• Intervention before risk factors develop • Sustainable • Does not require screening	• Directed at higher risk individuals • Tailored therapy • Patients motivated to implement changes	• Directed at highest risk individuals • Tailored therapy • Patients highly motivated to implement change
Disadvantages	• Difficult to implement • Hard to quantify effect • Up-front costs • Individual risk reduction small	• Requires screening of population • May delay but not prevent disease • "Medicalization" of asymptomatic individuals	• Small segment of population eligible • Attempts to attenuate loss of quality of life • Not sustainable

Preventive Cardiology, 2011

Mengapa penyakit jantung dan pembuluh darah pada perempuan harus dicegah?

Perempuan itu istimewa

Menstruasi
Mengandung
Melahirkan
Menyusui
Menopause





Hormon Estrogen

- Hormon yang terutama dihasilkan oleh indung telur (ovarium).
- Hormon yang melindungi jantung dan pembuluh darah (antioksidan, menumbuhkan pembuluh darah baru, melebarkan pembuluh darah, mencegah penyempitan pembuluh darah, meningkatkan kadar kolesterol HDL dan menurunkan kadar kolesterol LDL, mencegah kematian sel).

Menopause
(alami/karena tindakan tertentu)



Menurunkan proteksi/perlindungan terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah pada perempuan.

PENYEBAB KEMATIAN PADA PEREMPUAN

	Women (%)	Men (%)
Heart disease + stroke	29.7	29.1
Heart disease	23.5	24.9
Cancer	22.1	24.4
Stroke	6.2	4.2
Chronic lower respiratory diseases	5.9	5.3
Alzheimer disease	4.7	2.1
Unintentional injuries	3.6	6.2
Diabetes	2.7	2.9
Suicide	0.7	2.5
Influenza and pneumonia	2.1	1.9
Kidney disease	2.1	2.0
Septicemia	1.5	1.3

From Centers for Disease Control. Deaths, percent of total deaths, and death rates for the 15 leading causes of death in selected age groups, by race and sex: United States, 2011. Available at: http://www.cdc.gov/nchs/data/dvs/LCWK3_2011.pdf. Med Clin N Am 99 (2015) 535–552.

Penyakit Kardiovaskular Penyebab Kematian pada Perempuan Berdasarkan Ras/Etnis

Race/Ethnicity	Heart Disease (%)	Stroke (%)	Diabetes (%)	Kidney Disease (%)	Hypertension (%)
Black	24.1	6.4	4.6	3.4	2.1
White	23.5	6.2	2.4	1.9	—
Asian/Pacific Islander	21.3	8.5	3.7	2.3	1.9
Hispanic	20.9	6.0	4.9	2.4	—
American Indian/Alaska Native	16.8	4.3	6.0	2.6	—
All races	23.5	6.2	2.7	2.1	—

From Centers for Disease Control, Leading Causes of Death in Females. 2010 Data. Available at:: http://www.cdc.gov/women/lcod/.
Med Clin N Am 99 (2015) 535–552.

Prevalensi Penyakit Jantung berdasarkan Diagnosis Dokter pada Penduduk Semua Umur menurut Provinsi

Provinsi	Penyakit jantung		N tertimbang
	%	95% CI	
Aceh	1,6	1,5 - 1,8	20.244
Sumatera Utara	1,3	1,2 - 1,5	55.351
Sumatera Barat	1,6	1,4 - 1,8	20.663
Riau	1,1	0,9 - 1,2	26.085
Jambi	0,9	0,7 - 1,1	13.692
Sumatera Selatan	1,2	1,0 - 1,4	32.126
Bengkulu	1,3	1,1 - 1,5	7.531
Lampung	1,2	1,1 - 1,4	32.148
Bangka Belitung	1,5	1,2 - 1,8	5.592
Kepulauan Riau	1,5	1,2 - 1,9	8.173
DKI Jakarta	1,9	1,7 - 2,2	40.210
Jawa Barat	1,6	1,5 - 1,7	186.809
Jawa Tengah	1,6	1,5 - 1,7	132.565
DI Yogyakarta	2,0	1,7 - 2,3	14.602
Jawa Timur	1,5	1,4 - 1,6	151.878
Banten	1,4	1,2 - 1,5	48.621
Bali	1,3	1,2 - 1,5	16.481
Nusa Tenggara Barat	0,9	0,7 - 1,1	19.247
Nusa Tenggara Timur	0,7	0,6 - 0,8	20.599
Kalimantan Barat	1,3	1,2 - 1,5	19.190
Kalimantan Tengah	1,3	1,1 - 1,5	10.189
Kalimantan Selatan	1,3	1,1 - 1,5	16.043
Kalimantan Timur	1,9	1,6 - 2,2	13.977
Kalimantan Utara	2,2	1,8 - 2,7	2.733
Sulawesi Utara	1,8	1,5 - 2,0	9.542
Sulawesi Tengah	1,9	1,7 - 2,2	11.548
Sulawesi Selatan	1,5	1,3 - 1,6	33.693
Sulawesi Tenggara	1,4	1,2 - 1,6	10.167
Gorontalo	2,0	1,6 - 2,4	4.547
Sulawesi Barat	1,5	1,2 - 2,0	5.195
Maluku	1,5	1,2 - 1,7	6.801
Maluku Utara	1,1	0,9 - 1,4	4.723
Papua Barat	1,2	0,9 - 1,5	3.588
Papua	0,9	0,7 - 1,0	12.736
INDONESIA	**1,5**	**1,4 - 1,5**	**1.017.290**

Prevalensi Penyakit Jantung berdasarkan Diagnosis Dokter pada Penduduk Semua Umur menurut Karakteristik

Karakteristik	Penyakit jantung		N tertimbang
	%	95% CI	
Kelompok umur			
< 1	0,1	0,1 - 0,2	18.225
1-4	0,4	0,3 - 0,4	73.188
5-14	0,7	0,6 - 0,7	182.338
15-24	0,7	0,6 - 0,8	165.644
25-34	0,8	0,8 - 0,9	159.708
35-44	1,3	1,2 - 1,4	151.539
45-54	2,4	2,3 - 2,6	124.652
55-64	3,9	3,7 - 4,1	83.251
65-74	4,6	4,3 - 4,9	40.180
75+	4,7	4,3 - 5,2	18.565
Jenis kelamin			
Laki-laki	1,3	1,3 - 1,4	510.714
Perempuan	1,6	1,6 - 1,7	506.576
Pendidikan			
Tidak/belum pernah sekolah	1,8	1,6 - 1,9	70.895
Tidak tamat SD/MI	1,5	1,4 - 1,6	181.429
Tamat SD/MI	1,8	1,7 - 1,8	215.967
Tamat SLTP/MTS	1,4	1,3 - 1,5	160.320
Tamat SLTA/MA	1,5	1,4 - 1,6	210.746
Tamat D1/D2/D3/PT	2,1	2,0 - 2,3	64.093
Pekerjaan			
Tidak bekerja	2,3	2,2 - 2,4	233.629
Sekolah	0,6	0,6 - 0,7	126.626
PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD	2,7	2,5 - 3,0	21.931
Pegawai swasta	1,2	1,1 - 1,3	75.781
Wiraswasta	1,9	1,8 - 2,0	105.489
Petani/buruh tani	1,5	1,5 - 1,6	133.261
Nelayan	1,3	1,0 - 1,7	5.556
Buruh/sopir/pembantu ruta	1,2	1,1 - 1,3	75.590
Lainnya	2,3	2,1 - 2,5	40.644
Tempat tinggal			
Perkotaan	1,6	1,6 - 1,7	556.419
Perdesaan	1,3	1,2 - 1,3	460.871

SELF MONITORING !
Know Your Risks !



Perempuan harus mengetahui, memeriksakan diri dan bertanya kepada dokter tentang faktor risiko untuk penyakit kardiovaskular yang mungkin dapat terjadi pada dirinya.

FAKTOR RISIKO PENYAKIT KARDIOVASKULAR PADA PEREMPUAN

TRADISIONAL

- Dislipidemia
- Diabetes
- Hipertensi
- Obesitas/*overweight*
- Kurang beraktivitas fisik
- Stres
- Merokok

NON TRADISIONAL

- Depresi
- Menopause
- Terapi kanker payudara
- Penyakit autoimun
- Hipertensi pada kehamilan
- Kelahiran prematur
- Diabetes pada saat kehamilan
- Sindrom polikistik ovarium

J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2019 Sep;20(9):575-583.
Circ Res. 2016;118:1273-1293. Circulation. 2017;135:495–498.

DISLIPIDEMIA

- Kolesterol HDL lebih prediktif dibanding kolesterol LDL untuk risiko PJK.
- Lipoproten(a) yang meningkat (>50 mg/dL) pada usia<66 tahun, risiko PJK lebih tinggi.
- Trigliserida yang tinggi lebih berpengaruh pada perempuan lansia.



N C Med J. 2016;77(6):406-409

PENCEGAHAN

- Pengaturan diet yang tepat (rendah kolesterol)
- Olahraga
- Terapi: Statin (pencegahan primer dan pencegahan sekunder).



N C Med J. 2016;77(6):406-409
Curr Probl Cardiol 2012;37:450-526.

Pencegahan



- Diet rendah gula/glukosa
- Pertahankan berat badan tubuh ideal (Indeks massa tubuh normal 18,5 – 25,0 kg/m2)
- Lingkar pinggang: < 80 cm
- Olahraga: Perempuan DM membutuhkan frekuensi dan intensitas olahraga yang lebih besar untuk dapat menurunkan kejadian serangan jantung.
- Bila sudah mengidap DM, sebaiknya minum obat DM secara rutin dan teratur.

N C Med J. 2016;77(6):406-409
Curr Probl Cardiol 2012;37:450-526.

Hipertensi



- Prevalensi HT pada perempuan berusia >60 th, lebih tinggi dibanding laki-laki.
- Perempuan berusia >75 th, lebih banyak yang mengalami HT dibanding laki-laki (80%).
- HT pada perempuan kurang terkontrol dibanding laki-laki.

N C Med J. 2016;77(6):406-409
Curr Probl Cardiol 2012;37:450-526.

Pencegahan



- Mengurangi konsumsi garam. **Natrium (Na) sebaiknya tidak lebih dari 2 gram/hari** (setara dengan 5-6gram NaCl perhari atau 1 sendok teh garam dapur).
- Mengurangi konsumsi alkohol.
- Konsumsi makanan seimbang yang mengandung sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan segar, produk susu rendah lemak, gandum, ikan, dan asam lemak tak jenuh (terutama minyak zaitun), serta membatasi asupan daging merah dan asam lemak jenuh
- Pengendalian berat badan.
- Minum obat HT secara rutin dan teratur.

N C Med J. 2016;77(6):406-409
Curr Probl Cardiol 2012;37:450-526.

Pencegahan



	Nonpharmacological Intervention	Goal	Approximate Impact on SBP		
			Hypertension	Normotension	Reference
Weight loss	Weight/body fat	Best goal is ideal body weight, but aim for at least a 1-kg reduction in body weight for most adults who are overweight. Expect about 1 mm Hg for every 1-kg reduction in body weight.	-5 mm Hg	-2/3 mm Hg	S4.4-2
Healthy diet	DASH dietary pattern†	Consume a diet rich in fruits, vegetables, whole grains, and low-fat dairy products, with reduced content of saturated and total fat.	-11 mm Hg	-3 mm Hg	S4.4-7, S4.4-8
Reduced intake of dietary sodium	Dietary sodium	Optimal goal is <1500 mg/d, but aim for at least a 1000-mg/d reduction in most adults.	-5/6 mm Hg	-2/3 mm Hg	S4.4-10, S4.4-12
Enhanced intake of dietary potassium	Dietary potassium	Aim for 3500–5000 mg/d, preferably by consumption of a diet rich in potassium.	-4/5 mm Hg	-2 mm Hg	S4.4-14
Physical activity	Aerobic	90–150 min/wk 65%–75% heart rate reserve	-5/8 mm Hg	-2/4 mm Hg	S4.4-19, S4.4-20
	Dynamic resistance	90–150 min/wk 50%–80% 1 rep maximum 6 exercises, 3 sets/exercise, 10 repetitions/set	-4 mm Hg	-2 mm Hg	S4.4-19
	Isometric resistance	4 × 2 min (hand grip), 1 min rest between exercises, 30%–40% maximum voluntary contraction, 3 sessions/wk 8–10 wk	-5 mm Hg	-4 mm Hg	S4.4-21, S4.4-78
Moderation in alcohol intake	Alcohol consumption	In individuals who drink alcohol, reduce alcohol‡ to: Men: ≤2 drinks daily Women: ≤1 drink daily	-4 mm Hg	-3 mm Hg	S4.4-20, S4.4-24, S4.4-25

Circulation. 2019;140:e596–e646

Age group	Office SBP treatment target ranges (mmHg)					Office DBP treatment target range (mmHg)
	Hypertension	+ Diabetes	+ CKD	+ CAD	+ Stroke[a]/TIA	
18 - 65 years	**Target to 130** *or lower if tolerated* Not <120	**Target to 130** *or lower if tolerated* Not <120	**Target to <140 to 130** *if tolerated*	**Target to 130** *or lower if tolerated* Not <120	**Target to 130** *or lower if tolerated* Not <120	70–79
65 - 79 years[b]	**Target to 130-139** *if tolerated*	**Target to 130-139** *if tolerated*	**Target to 130-139** *if tolerated*	**Target to 130-139** *if tolerated*	**Target to 130-139** *if tolerated*	70–79
≥80 years[b]	**Target to 130-139** *if tolerated*	**Target to 130-139** *if tolerated*	**Target to 130-139** *if tolerated*	**Target to 130-139** *if tolerated*	**Target to 130-139** *if tolerated*	70–79
Office DBP treatment target range (mmHg)	70–79	70–79	70–79	70–79	70–79	

©ESC/ESH 2018

CAD = coronary artery disease; CKD = chronic kidney disease (includes diabetic and non-diabetic CKD); DBP = diastolic blood pressure; SBP = systolic blood pressure; TIA = transient ischaemic attack.

[a]Refers to patients with previous stroke and does not refer to blood pressure targets immediately after acute stroke.

[b]Treatment decisions and blood pressure targets may need to be modified in older patients who are frail and independent.

European Heart Journal (2018) 39, 3021–3104

OBESITAS

- Dampak obesitas terhadap timbulnya PJK, lebih besar pada perempuan dibandingkan laki-laki.
- Obesitas meningkatkan risiko terjadinya PJK pada perempuan sebesar 64%, dibandingkan laki-laki (46%).



INDEKS MASSA TUBUH

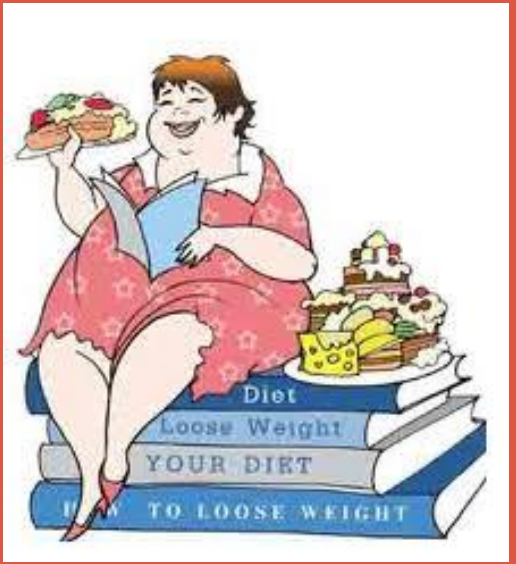
- Indeks massa tubuh (IMT) adalah indeks sederhana untuk berat badan terhadap tinggi badan yang digunakan untuk mengklasifikasikan kelebihan berat badan dan obesitas pada orang dewasa.
- IMT didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kilogram dibagi dengan kuadrat tinggi badan dalam meter (kg/m2).
- Rumus untuk menghitung IMT adalah sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Berat Badan [kg]})}{(\text{Tinggi Badan [meter]})^2}$$

Kategori		Indeks Massa Tubuh (kg/m^2)
Kurus	Kekurangan berat badan tingkat berat	<17,0
	Kekurangan berat badan tingkat ringan	17,0 – 18,4
Normal		18,5 – 25,0
Gemuk	Kelebihan berat badan tingkat ringan	25,1 - 27,0
	Kelebihan berat badan tingkat berat	>27,0

OLAHRAGA EFEKTIF UNTUK MENGONTROL BERAT BADAN

- Lemak tubuh dapat hilang/berkurang pada individu obes, bila melakukan latihan *endurance*/ketahanan.
- Berat badan berkurang ~ 3kg: Latihan *endurance* 16 minggu, tanpa diet.
- Latihan <150 menit/minggu, tidak memberikan perubahan berat badan yang signifikan pada individu obes.
- Latihan >150 menit/minggu, berat badan berkurang ± 2-3 kg.
- Latihan >224 – 420 menit/minggu dapat menurunkan berat badan ± 5 – 7,5 kg.



European Journal of Preventive Cardiology, 2012;19 issue 5 : 1005- 1033

Prevalensi gaya hidup sedenter dan kurang aktivitas, lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki.

AKTIVITAS FISIK



Circ Res. 2016;118:1273-1293

Definition

- **Physical activity**
  Any bodily movement produced by the contraction of skeletal muscle that increases energy expenditure **above a basal level**.

  Physical activity generally refers to the subset of physical activity that enhances health.

- **Exercise**
  A **subcategory of physical activity that is planned, structured, repetitive, and purposive** in the sense that the improvement or maintenance of one or more components of physical fitness is the objective

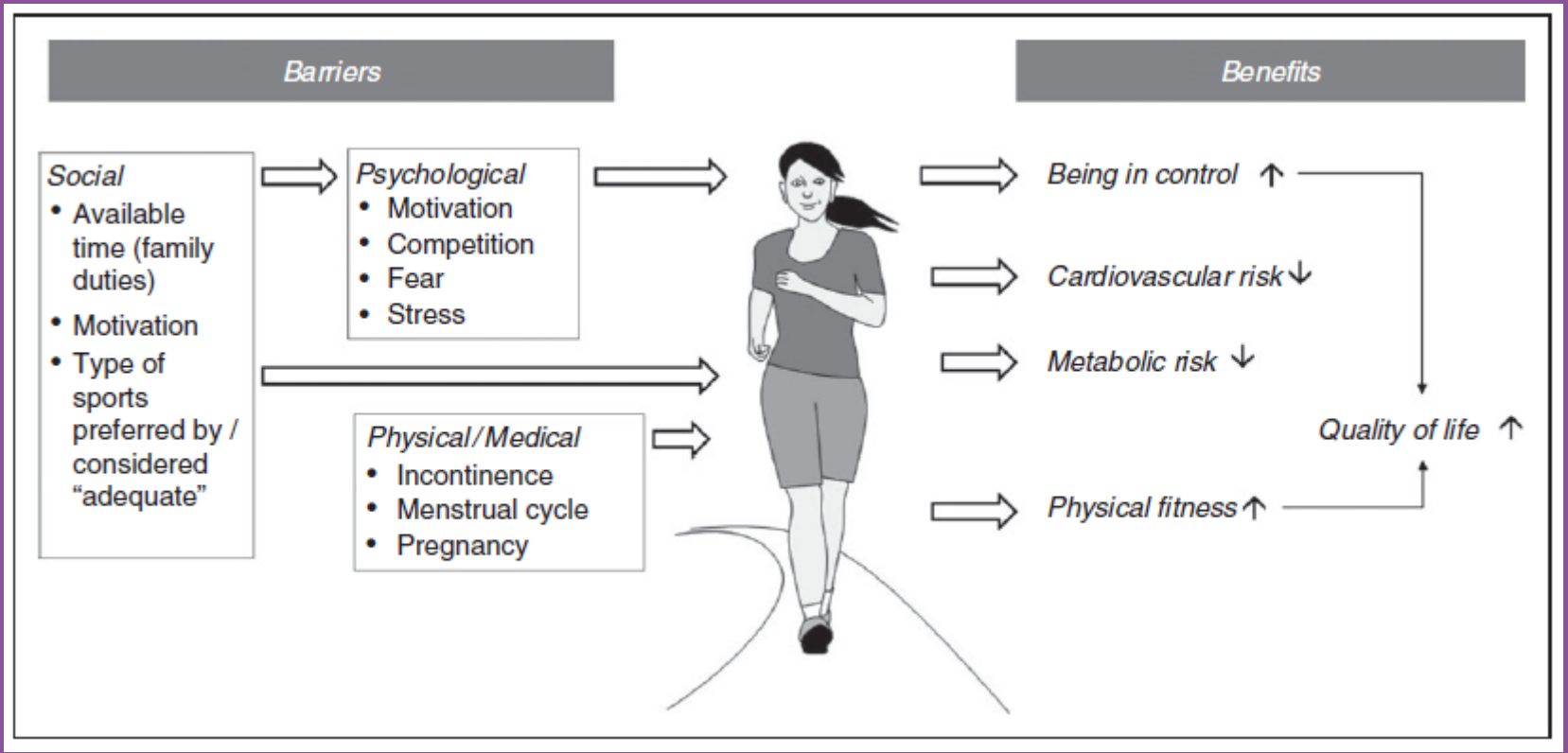
Nat Rev Immunol. 2019 Sep;19(9):563-572

ELEMENTS OF PHYSICAL ACTIVITY

PHYSICAL ACTIVITY	EXERCISE
Bodily movement via skeletal muscles	Bodily movement via skeletal muscles
Results in energy expenditure	Results in energy expenditure
Energy expenditure (kilocalories) varies continuously from low to high	Energy expenditure (kilocalories) varies continuously from low to high
Positively correlated with physical fitness	Very positively correlated with physical fitness
	Planned, structured, and repetitive bodily movement
	An objective is to improve or maintain physical fitness component(s)

Public Health Rep 1985;100(2):126–131.

LATIHAN FISIK PADA PEREMPUAN



Eur J Prev Cardiol. 2019 Mar 19;2047487319838221

REKOMENDASI LATIHAN FISIK

Rekomendasi **latihan fisik aerobik** untuk dewasa di semua usia:

- Setidaknya 150 – 300 menit dalam seminggu dengan intensitas sedang.

ATAU

- Setidaknya 75 – 150 menit dalam seminggu dengan intensitas berat.



European Heart Journal (2021) 42, 3227-3337

KLASIFIKASI INTENSITAS LATIHAN FISIK

Absolute intensity			Relative intensity		
Intensity	**MET[a]**	**Examples**	**%HR_{max}**	**RPE (Borg scale score)**	**Talk test**
Light	1.1–2.9	Walking <4.7 km/h, light household work	57–63	10–11	
Moderate	3–5.9	Walking at moderate or brisk pace (4.1–6.5 km/h), slow cycling (15 km/h), painting/decorating, vacuuming, gardening (mowing lawn), golf (pulling clubs in trolley), tennis (doubles), ballroom dancing, water aerobics	64–76	12–13	Breathing is faster but compatible with speaking full sentences
Vigorous	≥6	Race-walking, jogging, or running, cycling >15 km/h, heavy gardening (continuous digging or hoeing), swimming laps, tennis (singles)	77–95	14–17	Breathing very hard, incompatible with carrying on a conversation comfortably

© ESC 2021

%HR_{max} = percentage of measured or estimated maximum heart rate (220–age); MET = metabolic equivalent of task; RPE = rating of perceived exertion (Borg-scale 6–20); VO_2 = oxygen consumption.

[a]MET is estimated as the energy cost of a given activity divided by resting energy expenditure: 1 MET = 3.5 mL oxygen kg^{-1} min^{-1} VO_2.

Modified from [392]

European Heart Journal (2021) 42, 3227-3337

STRES

- Ketidakseimbangan antara kemampuan untuk beradaptasi terhadap tuntutan lingkungan dan paparan berlebihan terhadap lingkungan, menyebabkan stres lebih tinggi pada perempuan, terutama pada usia paruh baya,menyebabkan peningkatan risiko penyakit kardiometabolik melalui resistensi insulin, neuroendokrin, otonom dan mediator imun.

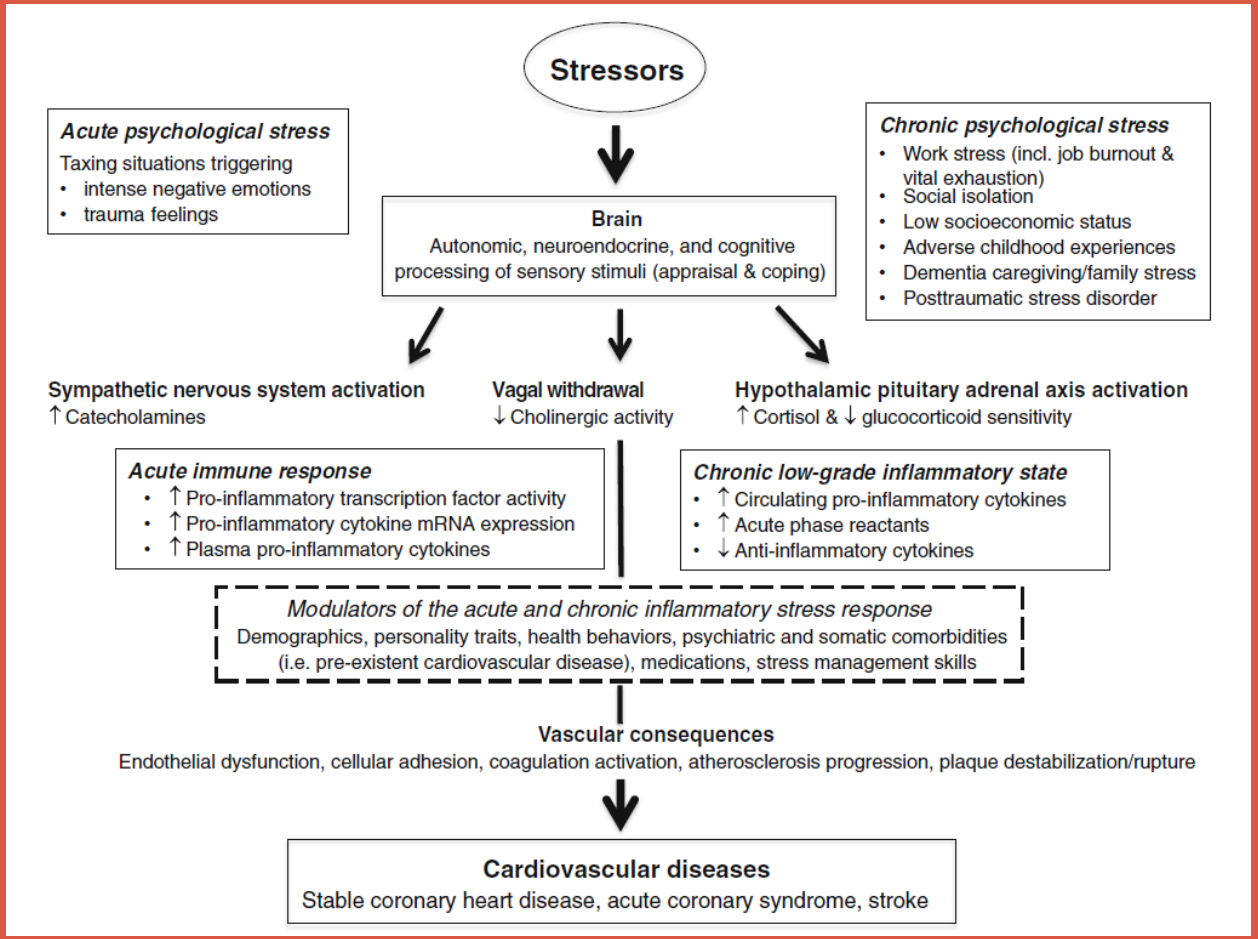
- Stres dapat menyebabkan penyakit kardiomiopati (Sindrom Takotsubo), yg utamanya terjadi pada perempuan pascamenopause.

- Gangguan mental dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, prognosis yang lebih buruk pada pasien dengan penyakit kardiovaskular, penyebab kematian lainnya, termasuk bunuh diri.



J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2019 Sep;20(9):575-583
European Heart Journal (2021) 42, 3227-3337.

STRES SEBAGAI FAKTOR RISIKO PENYAKIT KARDIOVASKULAR



Curr Cardiol Rep (2017) 19:111

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Sehatkah Jiwa Anda

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

CARA MENGONTROL STRES



Kenali perasaan Anda
seperti marah, takut, sedih, iri, cemas, senang, dll pada setiap situasi

Coba untuk mengerti
apa yang menyebabkan perasaan tersebut

Perhatikan
apa yang Anda lakukan terhadap orang lain dan diri sendiri ketika timbul perasaan tersebut

Sadari kemampuan dan keterbatasan Anda
dalam menghadapi situasi tersebut dan cobalah untuk bersikap rasional

Kenalilah cara Anda mengatasi perasaan dan masalah.
apakah berhasil atau tidak ? Misalnya ketika Anda merasa marah, tanyakah pada diri Anda : Mengapa saya marah ? kepada siapa saya marah ? Apa yang biasanya saya lakukan ketika marah ? Apa yang dapat saya lakukan untuk mengatasi rasa marah ?

Pelajari cara baru
yang dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan Anda dalam mengatasi perasaan Anda, tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain

Rencanakan
cara yang positif untuk mengatasi perasaan ini selangkah demi selangkah.

Lakukan
rencana Anda

Rencanakan kembali
cara yang baru bila hasilnya kurang memuaskan.

Image by Freepik

www.p2ptm.kemkes.go.id @p2ptmkemenkesRI @p2ptmkemenkesRI @p2ptmkemenkesRI

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

Bagaimana Mengatasi Rasa Tidak Nyaman Karena Stres?



Jaga kesehatan dengan olahraga teratur, tidur yang cukup, makan bergizi seimbang, dan berperilaku hidup bersih dan sehat

Melakukan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan kita





Berpikir hal-hal yang baik dan menyenangkan



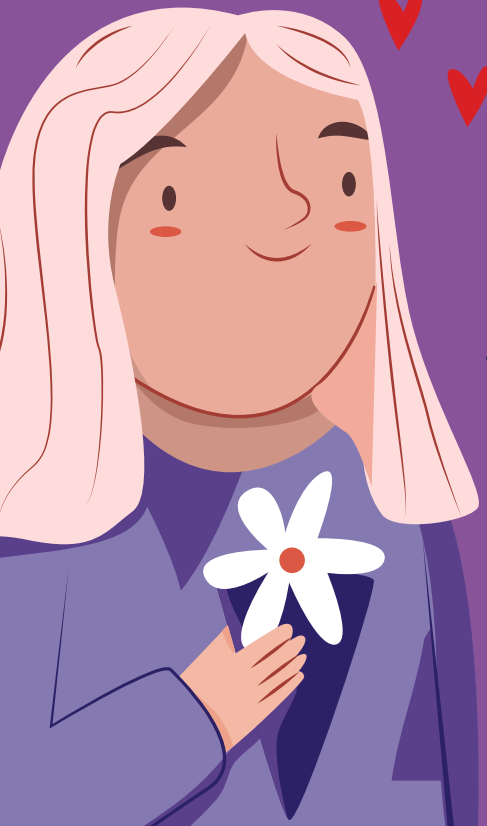
Tenangkan pikiran dan kembangkan hobi

Bicarakan perasaan dan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya



Meningkatkan ibadah sesuai dengan agama masing-masing

p2ptm.kemkes.go.id @p2ptmkemenkesRI @p2ptmkemenkesRI @p2ptmkemenkesri



MEROKOK

- Perempuan yang merokok, akan mengalami peningkatan risiko PJK sebesar 25%, dibanding laki-laki.
- Merokok dikaitkan dengan separuh kejadian kardiovaskular pada perempuan dan tiga kali lipat risiko timbulnya serangan jantung (infark miokard).

Heart. 2019 Nov;105(21):1656-1660

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

CARA MENGHINDARI PENGARUH UNTUK MEROKOK

QUIT-LINE BERHENTI MEROKOK FREE CALL Service
0-800-177-6565

Hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok

Lakukan hal-hal positif lainnya, seperti : olahraga, membaca atau hobi lain yang menyehatkan

Yakinlah, bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan

Hindari sesuatu yang terkait tentang rokok (sponsor, iklan, poster, rokok gratis)

Jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok

Perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

#EnyahkanAsapRokok

GERMAS Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

TIPS BERHENTI MEROKOK

Kuatkan niat, bulatkan tekad



Minta bantuan kerabat dan keluarga

Atur target waktu, kapan Anda berhenti merokok



Cari kesibukan lain



Banyak minum air putih



Jauhi lingkungan para perokok

Tetap berpikir positif





Image by Freepik



MANFAAT BERHENTI MEROKOK

https://www.klikparu.com/2019/04/manfaat-berhenti-merokok.html

Stepping to Success: Reducing CVD Risk in Women

Step 1

Screen for Sex-specific Risk Factors:

- Prematurity
- Age at menarche
- Polycystic ovarian syndrome
- Hormone-based contraceptive use
- Recurrent spontaneous pregnancy loss
- Gestational diabetes
- Gestational HTN
- Pre-eclampsia
- Pre-term delivery
- Delivery of small for gestational age infant
- Early menopause/ premature ovarian failure

Step 2

If sex-specific risk factors are present:

1. Assess for traditional CVD risk factors early and more frequently

2. Screen for, prevent, & treat intermediate phenotypes

Hypertension
Diabetes
Hyperlipidemia
Metabolic Syndrome

Step 3

Begin aggressive risk factor management

Implement lifestyle modifications with AHA's Life's Simple 7:

1. Manage blood pressure
2. Control cholesterol
3. Reduce blood sugar
4. Stay active
5. Eat Healthy
6. Lose weight
7. Stop Smoking



Step 4

Estimate risk & treat accordingly with consideration of sex-specific risk factors:

1. Assess 10-year ASCVD Risk/ Lifetime risk

2. Treat early if borderline or intermediate risk and if sex-specific risk factors are present

TERIMA KASIH

Semoga dapat bermanfaat